

チューブ・カテーテル自己抜去・事故抜去時の標準的対処方法 ①

種類	医師への報告	対応
CVカテーテル	主治医と当直医にすぐに報告	空気の血管内への流入を防ぐため、発見したら速やかに刺入部を圧迫する。圧迫後、出血がない場合は、IV3000 フィルムで被覆する。何cm抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、全部抜けている場合は、体内残存がないか先端の形状を確認する。
PICC	主治医と当直医にすぐに報告	何cm抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、全部抜けている場合は、体内残存がないか先端の形状を確認する。 出血しているようなら圧迫止血する。
末梢輸液ルート	状況に応じて報告	刺入部、寝具類の観察。出血しているようなら圧迫止血。どのくらいの出血があり、輸液がどれくらい外に漏れているか周囲の状況から予測し、必要時医師に報告する。抜けたばかりで出血や輸液の損失もほぼない状況であれば、状況を記載し、ルートをとりなおし、輸液を再開、後で医師に報告する。
膀胱留置カテーテル	状況に応じて報告	血尿の有無、性状、バイタルサインの変化等観察する。 男性の場合は、前立腺出血の可能性があるので、特に注意して観察し、出血している場合は、速やかに医師に報告する。抜けているチューブの状態、カフの状況、チューブがちぎれている場合は先端の確認を行う。再挿入するかどうかは医師に確認する。
気管切開チューブ	主治医と当直医にすぐに報告	何cm抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、呼吸状態、意識レベル、バイタルサイン、SPO2の観察を行い、速やかに医師に報告する。自発呼吸がある場合は、酸素を気管切開部に当てて医師を待つ。 自発呼吸がない場合、あるいは弱い場合は、気管切開孔をガーゼなどで押さえてふさぎ、口から蘇生バッグで手動式換気を行う。再挿入に備え、カニューレの準備をして医師を待つ。
挿管チューブ	主治医と当直医にすぐに報告	何cm抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、呼吸状態、意識レベル、バイタルサイン、SPO2の観察を行い、速やかに医師に報告する。自発呼吸がある場合は、酸素を吸入させながら医師を待つ。 自発呼吸がない場合、あるいは弱い場合は、蘇生バッグで手動式換気を行う。再挿管に備えて挿管準備をして医師を待つ。

*** 緊急性の高いものは、当直医に先に報告する。**

チューブ・カテーテル自己抜去・事故抜去時の標準的対処方法 ②

種類	医師への報告	対応
酸素	状況に応じて報告	すぐに酸素吸入を開始し、SPO2測定、意識レベル、バイタルサインの観察を行う。
胃管チューブ イレウスチューブ	主治医と当直医にすぐに報告	何 c m 抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、 今までの排液量、排液の性状等確認し、医師に速やかに報告する。
胃ろうチューブ	主治医と当直医にすぐに報告	何 c m 抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、 栄養中であれば栄養をすぐ中止して、医師に速やかに報告する。
経鼻栄養カテーテル	主治医と当直医にすぐに報告	栄養注入中であれば誤嚥した可能性がある。栄養をすぐに中止し、 呼吸状態、意識状態、バイタルサイン等の観察を行い、医師に速やか報告する。数 c m 抜けている場合は、テンプレート「経鼻栄養チューブ挿入記録用紙」を用いて、テンプレートの確認方法に沿って、その時点で、チューブが胃内に入っているかを確認する。胃内に入っていないと判断した場合、あるいは明らかに胃から抜けていると判断した場合は、そのままチューブを引き抜き、手順に従って再挿入する。
腹腔ドレーン	主治医と当直医にすぐに報告	何 c m 抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、 今までの排液量、排液の性状、刺入部からの出血の有無等を確認し 医師に速やかに報告する。チューブが全部抜けていない場合は、その状態からチューブが動かない様に固定して、医師を待つ。
胸腔ドレーン	主治医と当直医にすぐに報告	何 c m 抜けたのか、あるいは全部抜けたのか、 今までの排液量、排液の性状、刺入部からの出血の有無、 エアリークの有無、バイタルサイン、SPO2等確認し 医師に速やかに報告する。チューブが全部抜けていない場合は、その状態からチューブが動かない様に固定して、医師を待つ。
術後ドレーン (SBドレーン等)	主治医と当直医にすぐに報告	これまでの排液の状況、バイタルサイン、刺入部からの出血量、抜去されたドレーンの体内残存がないかどうかを確認する。

*** 緊急性の高いものは、当直医に先に報告する。**